

AI Report

We predict this text is

Human Generated

AI Probability

31%

This number is the probability that the document is AI generated, not a percentage of AI text in the document.

Plagiarism

Plagiarism scan was not run for this document.

Laporan_MPSI_Raihan Isad_revised.pdf - 7/23/2026

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) TEREGLASI

Mata Kuliah: Manajemen Proyek Sistem Informasi (MPSI)

Disusun oleh:

Raihan Isad (NIM: 20240803024)

Program Studi: Sistem Informasi,

Fakultas Ilmu Komputer,

Universitas Esa Unggul

Daftar Isi

| DAFTAR ISI ... | Error!
Bookmark not defined.
|

| --- | --- |

| 1.
PENDAHULUAN... | 3 |

| 1.1.
Latar Belakang ... | 3 |

| 2.
ISI LAPORAN... | 3 |

| 2.1.
Bagian A: Inisiasi Proyek & Business Case... | 3 |

| Rincian Anggaran Finansial Proyek: ... | 4 |

| Total Anggaran Proyek: Rp 4.500.000.000 Risiko Utama Tingkat Tinggi: ... | 5 |

| Wewenang Manajer Proyek:... | 5 |

| Estimasi Manfaat Nyata (Tangible) per Tahun:... | 6 |

| 2.2.
Bagian B: Perencanaan Lingkup & Struktur Rincian Kerja... | 7 |

| • Must Have (Wajib Ada): ... | 8 |

| • Should Have (Sangat Penting): ... | 9 |

| • Could Have (Tambahan): ... | 9 |

| • Won't Have (Ditunda): ... | 9 |

| 2.3.
Bagian C: Penjadwalan, Biaya, & Metodologi... | 9 |

| 2.4.
Bagian D: Manajemen Risiko & Kualitas ... | 11 |

| Total Nilai Kerugian EMV: Rp 900.000.000... | 11 |

| 2.5.
Bagian E: Sumber Daya Manusia, Komunikasi, & Pengadaan... | 12 |

| 2.6.
Bagian F: Implementasi, Deployment, & Manajemen Perubahan ... | 13 |

| Jadwal Peluncuran (Cutover Plan):... | 13 |

| 2.7.
Bagian G: Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, & Penutupan ... | 14 |

| Data minggu ke-12: ... | 14 |

| Perhitungan Indikator: ... | 14 |

| Proyeksi Perkiraan Biaya Akhir (EAC):... | 14 |

| 3.
DAFTAR PUSTAKA ... | Error!
Bookmark not defined.

| 4.
LAMPIRAN... | Error!
Bookmark not defined.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kasus

Dalam rangka menyongsong Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Rekam Medis, maka rumah sakit di Indonesia harus menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS yang langsung terkoneksi ke platform nasional SATUSEHAT oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hanspital adalah rumah sakit kelas B yang kapasitasnya mencapai 300 tempat tidur dan sekarang rumah sakit tersebut belum menggunakan sistem informasi yang sudah terintegrasikan serta pencatatan data sebagian besar dilakukan secara manual.

Maka dari itu, karena belum adanya hubungan yang baik di antara satu bagian dengan bagian lain, sering kali data ganda dan terjadi kesalahan pencatatan rekam medis dan proses pelayanan pasien menjadi tidak efektif.

Berdasarkan beberapa penelitian, penerapan SIMRS yang telah terintegrasikan ternyata dapat mampu menurunkan kesalahan pencatatan data pasien, terutama pada bagian diagnosis penyakit dan berkas klaim BPJS Kesehatan.

Hal ini diperlukan agar rumah sakit tidak mengalami masalah.

Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) serta integrasinya ke dalam SATUSEHAT menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan standar layanan dan pertukaran informasi kesehatan yang lebih baik.

Proyek ini dirancang untuk memperkenalkan sistem aplikasi SIMRS yang terintegrasi dengan 7 modul yang meliputi: registrasi pasien, rekam medis elektronik, kalender klinik, apotek, laboratorium, radiologi, billing kasir, hingga asuransi. Semua modul ini dikoneksikan secara real-time ke SATUSEHAT.

Proyek ini dikembangkan untuk mengimplementasikan sistem SIMRS yang terintegrasi dan berisi 7 modul: pendaftaran pasien, rekam medis, jadwal poliklinik, farmasi, laboratorium, radiologi, billing, cashier sampai claim insurance. Semua modul tersebut terintegrasi secara real-time dengan SATUSEHAT.

Proyek ini direncanakan akan berlangsung selama 24 minggu dengan total anggaran sebesar Rp 4.500.000.000.

2. ISI LAPORAN

2.1. Bagian A: Inisiasi Proyek & Business Case

A.1. Project Charter (Piagam Proyek)

| Aspek Proyek | Keterangan Detail |

| --- | --- |

| Nama Proyek | Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Regulasi |

| Sponsor Utama | Direktur Utama RS Hanspital |

| Manajer Proyek | Raihan Isad |

| Tanggal Otorisasi | 1 Agustus 2026 |

| Tujuan Strategis | - Membuat sistem rekam medis elektronik sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022. - Meningkatkan efisiensi kerja rumah sakit lewat otomatisasi. - Menghubungkan data rumah sakit ke platform SATUSEHAT Kemenkes.

| | - Mengurangi kesalahan input berkas klaim BPJS agar tidak rugi. - Mendorong rumah sakit mengurangi penggunaan kertas.

| --- | --- |

| Ruang Lingkup Makro | Kustomisasi dan pemasangan 7 modul utama SIMRS. Pembuatan sambungan API ke platform SATUSEHAT Kemenkes. Proses memindahkan (migrasi) data rekam medis dari sistem lama. Pelatihan penggunaan aplikasi untuk seluruh staf medis, perawat, dan admin. Beli dan pasang infrastruktur TI (server, jaringan, dan keamanan). Pengujian sistem, simulasi beban kerja, dan peluncuran (cutover).

| Batasan Eksplisit | - Menggunakan aplikasi dari vendor yang sudah jadi. - Tidak termasuk membeli perangkat keras alat medis fisik. - Tidak membuat integrasi ke asuransi swasta luar negeri. - Pembuatan aplikasi mobile pasien ditunda untuk fase berikutnya.

| Estimasi Durasi | Total waktu proyek adalah 24 minggu (termasuk persiapan, pengadaan, dan pendampingan pasca peluncuran) dengan berbasis 6 hari kerja per minggu.

| Faktor Sukses Kunci | Komitmen dan dukungan dari pihak pimpinan dan direksi. Kerjasama yang baik dari dokter, perawat, dan staf admin. Kebersihan dan ketepatan data hasil migrasi dari sistem lama. Penggunaan pelatihan user secara efektif sebelum penggunaan sistem. Performa aplikasi yang cepat dan jarang mengalami lamban.

| | |

Rincian Anggaran Finansial Proyek:

SIMRS Core Software License Cost: Rp 1,200.000.000

Information Technology Infrastructure (Server, Networking, and Security): Rp 800.000.000

Development and Customization of Modules: Rp 800.000.000

Database Data Clean-up and Migration: Rp 250.000.000

User Training and Change Management: Rp 375.000.000

Project Management and Consultant: Rp.400.000.000

Risk Money / Backup Money (15 persen dari total) : Rp675.000.000

Total Anggaran Proyek: Rp 4.500.000.000

Risiko Utama Tingkat Tinggi:

R-01: Staf medis menolak atau sulit beradaptasi dengan alur kerja baru di komputer.

R-02: Pengambilan data lama gagal sehingga data rekam medis hilang atau rusak.

R-03: Pengiriman server dari vendor terlambat.

R-04: Format API SATUSEHAT mendadak berubah dari Kemenkes.

Wewenang Manajer Proyek:

Mengelola penggunaan dana proyek sendiri selama variasi perubahan biaya di bawah 10%.

Menyusun dan mengatur anggota tim proyek bekerja sama dengan HRD.

Mengambil keputusan harian terkait penyesuaian jadwal dan tugas tim.

Menyetujui usulan perubahan lingkup proyek kategori kecil (minor change request).

- Melaporkan perkembangan proyek secara langsung ke Sponsor Utama dan Steering Committee.

A.2.

Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Estimasi Manfaat Nyata (Tangible) per Tahun:

- Hemat pengadaan kertas dan alat tulis kantor (ATK): Rp 120.000.000
- Efisiensi alokasi kerja tenaga administrasi: Rp 240.000.000
- Mencegah klaim BPJS ditolak akibat kesalahan input: Rp 500.000.000
- Hemat waktu pelayanan administrasi pasien: Rp 180.000.000

Total Manfaat Nyata Tahunan: Rp 1.040.000.000

Perhitungan Indikator Finansial:

Total investasi awal proyek adalah Rp 4.500.000.000.

Manfaat bersih tahunan didapat dari total manfaat nyata dikurangi biaya perawatan sistem tahunan (OpEx): Rp 1.040.000.000 - Rp 675.000.000 = Rp 365.000.000 per tahun.

Berdasarkan manfaat nyata berupa kas masuk, diperoleh Payback Period selama 12,3 tahun dan nilai Return on Investment (ROI) untuk jangka waktu 5 tahun berjumlah -34%.

Meskipun ROI tampak negatif bila dihitung berdasarkan pendapatan kas bersih saja, investasi ini masih menjadi investasi yang benar-benar worth it dan harus dilakukan.

Alasannya karena proyek ini menawarkan keuntungan intangible yang sangat penting, seperti mengikuti regulasi hukum pemerintah, klaim BPJS lancar, keselamatan pasien, dan membantu pelayanan rumah sakit.

Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan menggunakan matriks tingkat pengaruh (Power) dan kepentingan (Interest):

- Kuadran A (High Power, Low Interest - Keep Satisfied): Perwakilan Asuransi Komersial Eksternal, Komite Etik Kedokteran Rumah Sakit.
- Kuadran B (High Power, High Interest - Manage Closely): Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medis, Kepala IT (CIO), Vendor SIMRS, Dinas Kesehatan, serta Kepala Rekam Medis, Kepala Farmasi, dan Kepala Laboratorium.
- Kuadran C (Power Low, Interest High - Inform): Staff Registration, Specialist/Dokter Umum, Nurse Implementer, dan Keuangan.
- Kuadran D (Power Low, Interest Low - Monitor): Pasien dan Keluarga Pasien.

2.2.

Bagian B: Perencanaan Lingkup & Struktur Rincian Kerja

B.1.

Work Breakdown Structure (WBS)

| Kode WBS | Deliverable / Rincian Paket Kerja (Work Package) |

| --- | --- |

| 1.0 | Manajemen Proyek |

| 1.1 | Inisiasi Proyek (Project Charter, Analisis Stakeholder, Kick-off) |

| 1.2 | Perencanaan Terintegrasi (Project Plan, Rencana Risiko, Rencana Komunikasi) |

| 1.3 | Monitoring & Pengendalian (Laporan Mingguan, Rapat Steering, Change Control) |

| 1.4 | Penutupan Proyek (Laporan Akhir, Lessons Learned, Serah Terima) |

| 2.0 | Persiapan Infrastruktur TI |

| 2.1 | Analisis Kebutuhan Server & Jaringan |

| 2.2 | Pengadaan Perangkat (RFP, Evaluasi Vendor, Pembelian) |

| 2.3 | Pemasangan & Konfigurasi (Server, Jaringan, Database) |

| 3.0 | Pengembangan & Kustomisasi SIMRS |

| 3.1 | Analisis Kebutuhan Fungsional Alur Klinik |

| 3.2 | Konfigurasi Modul Inti (Pendaftaran, Rekam Medis Elektronik, Jadwal Poli) |

| 3.3 | Konfigurasi Modul Penunjang (Farmasi, Laboratorium, Radiologi) |

| 3.4 | Konfigurasi Modul Administrasi (Billing Kasir, Laporan Manajemen) |

| 3.5 | Pembuatan Sambungan API SATUSEHAT |

| 4.0 | Migrasi Data Database |

| 4.1 | Analisis & Audit Data Lama |

| 4.2 | Persiapan Migrasi (Pemetaan Kolom Data, Pembersihan Data, Pembuatan Skrip ETL) |

| 4.3 | Eksekusi & Validasi Migrasi (Uji Coba Migrasi, Validasi Sampel, Migrasi Akhir) |

| 5.0 | Pengujian Kualitas Sistem (Testing) |

| 5.1 | Pengujian Unit (Unit Testing) |

| 5.2 | Pengujian Integrasi Antar Modul (Integration Testing) |

| 5.3 | Pengujian Sistem Menyeluruh (Fungsi, Performa, Keamanan) |

| 5.4 | Pengujian User Acceptance Testing (UAT) & Sign-off |

| 6.0 | Pelatihan Pengguna & Change Management |

| 6.1 | Analisis Kebutuhan Pelatihan Pengguna |

| 6.2 | Penyusunan Buku Panduan & Video Tutorial |

| 6.3 | Pelaksanaan Pelatihan (Super User, Dokter, Perawat, Staf Admin) |

| 6.4 | Sosialisasi Perubahan & Penyiapan Desk Bantuan (Helpdesk) |

| 7.0 | Deployment Sistem & Go-Live |

| 7.1 | Persiapan Dokumen Transisi (Cutover Plan, Backup Data) |

| 7.2 | Peluncuran Sistem (Metode Pilot, Evaluasi, Full Deployment) |

| --- | --- |

| 7.3 | Pendampingan Teknis Pasca Go-Live (War Room & Support) |

B.2.

Scope Statement & Scope Baseline

- Fitur Dalam Lingkup (In-Scope): 7 Modul SIMRS (Pendaftaran, Rekam Medis Elektronik, Jadwal Poli, Farmasi, Laboratorium & Radiologi, Billing & Klaim BPJS, serta API SATUSEHAT Kemenkes).
- Luar Lingkup (Out-of-Scope): Aplikasi mobile Android/iOS pasien, integrasi asuransi luar negeri, beli alat medis fisik, buat sistem dari nol, dan pengaplikasian di rumah sakit cabang.
- Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria): Passing UAT sebesar 100%, time response dari aplikasi di bawah 3 detik selama jam sibuk, availability system sebesar 99.5%, accuracy migrasi data sebesar 100%, dan semua staf melewati uji coba penggunaan aplikasi.
serta Integrasi API SATUSEHAT Kementerian Kesehatan RI untuk mapping data variabel kesehatan, recording transaction medis sesuai regulasi, serta mengirim data otomatis secara aman.

B.3.

Product Backlog (Sistem Agile Scrum)

Pengelompokan fitur menggunakan metode MoSCoW:

• Must Have (Wajib Ada):

- US-01: Sebagai petugas pendaftaran, saya ingin mendaftarkan pasien baru dengan cepat agar pasien langsung dapat nomor rekam medis.
- US-02: Sebagai dokter spesialis, saya ingin menginput data rekam medis dan resep digital agar pencatatan rapi.
- US-03: Sebagai dokter, saya ingin melihat riwayat penyakit pasien agar keputusan tindakan medis tepat.
- US-04: Sebagai perawat, saya ingin menginput data tanda vital pasien agar terpantau tim medis.
- US-05: Sebagai petugas farmasi, saya ingin melihat e-resep masuk dan stok obat agar penyiapan obat akurat.
- US-06: Sebagai petugas kasir, saya ingin menghitung otomatis biaya tindakan dan BPJS agar proses bayar efisien.
- US-07: Sebagai sistem, aplikasi wajib mengirimkan data medis ke SATUSEHAT agar sesuai aturan

Kemenkes.

• Should Have (Sangat Penting):

US-08: Sebagai pasien, saya ingin melihat tampilan nomor antrean di layar ruang tunggu.

US-09: Sebagai manajer medis, saya ingin melihat dashboard ketersediaan tempat tidur secara langsung.

US-10: Sebagai staf admin, saya ingin mengubah jadwal praktik bulanan dokter.

• Could Have (Tambahan):

US-11: Sebagai direksi, saya ingin menerima ringkasan laporan pendapatan harian otomatis lewat email.

US-12: Sebagai petugas lab, saya ingin data mesin lab langsung masuk ke sistem SIMRS.

US-13: Sebagai perawat ICU, saya ingin sistem menampilkan peringatan jika hasil lab kritis keluar.

• Won't Have (Ditunda):

US-14: Sebagai pasien, saya ingin mengambil nomor antrean dari rumah pakai aplikasi hp.

US-15: Sebagai pasien, saya ingin konsultasi video call dengan dokter lewat aplikasi.

2.3.

Bagian C: Penjadwalan, Biaya, & Metodologi

C.1.

Pemilihan Metodologi Proyek

Method yang diaplikasikan dalam proyek ini adalah Hybrid Method (Predictive CPM & Adaptive Agile Scrum). Alasan dari pemilihan metode tersebut disebabkan proses implementasi server secara fisik maupun proses migration database membutuhkan proses yang terstruktur, sehingga pengembangannya menggunakan metode Critical Path Method (CPM). Akan tetapi, modul sistem SIMRS dan API SATUSEHAT membutuhkan tingkat fleksibilitas yang tinggi, maka diolah dengan metode Agile Scrum dengan cycle time 2 minggu.

Untuk menghindari scope creep, kita memfilter kebutuhan berdasarkan skala MoSCoW priority. Kebutuhan dokumentasi yang sedikit dalam metode Agile dikendalikan dengan membuat peta arsitektur dan buku pedoman yang harus ada di setiap sprint.

Penjadwalan Jalur Kritis (CPM/PDM)

ID	Nama Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor
---	---	---	---
A	Analisis Kebutuhan Fungsional Alur Klinis	10	-
B	Pengadaan Perangkat Server Hardware	14	A
C	Pemasangan & Konfigurasi Jaringan Server	10	B
D	Kustomisasi Modul Inti Aplikasi	15	A
E	Kustomisasi Modul Penunjang Klinis	10	D

| F | Pembuatan API SATUSEHAT | 12 | D |

| G | Persiapan & Skrip ETL Migrasi Data | 12 | A, C |

| H | Pengujian Integrasi Sistem Keseluruhan | 12 | C, D, E, F |

| I | Pengujian User Acceptance Testing (UAT) | 10 | H, G |

| J | Pelatihan Kelompok Super User | 8 | H |

| K | Pelatihan Kelompok Staf Massal | 12 | J |

| L | Eksekusi Migrasi Data Produksi (Cutover) | 5 | G, I |

| M | Peresmian Transisi Go-Live Sistem Baru | 3 | I, K, L |

| N | Pendampingan & Support Pasca Go-Live | 12 | M |

Analisis Penjadwalan:

Rute Jalur Kritis: A - D - F - H - J - K - M - N

Durasi Total Jalur Kritis Jalur Kritis: 84 Hari Kerja (atau 14 minggu,berdasarkan 6 hari kerja per minggu).

Explanasi Perbedaan Waktu: Waktu penerapan teknis adalah 84 hari kerja (sama dengan 14 minggu berdasarkan 6 hari kerja).

Perbedaan waktu sampai 24 minggu seperti yang dicantumkan dalam Project Charter adalah waktu buffer.

Waktu tersebut diperlukan untuk keperluan administrasi awal, menunggu pengiriman server dari luar negeri, dan hypercare sistem pasca peluncuran (hypercare).

C.2.

Estimasi Biaya Berbasis 3-Tier (Sampel Modul Utama)

Perhitungan estimasi biaya 3 titik (PERT) menggunakan rumus: $E = (O + 4M + P) / 6$

Modul Utama | Optimis (O) | Most Likely (M) | Pessimistic (P) | Expected Value (E) |

| --- | --- | --- | --- | --- |

Rekam Medis Elektronik (RME) | Rp 250.000.000 | Rp 350.000.000 | Rp 500.000.000 | Rp 358.333.333 |

Billing Kasir & Klaim BPJS | Rp 180.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp 380.000.000 | Rp 260.000.000 |

Jembatan API SATUSEHAT | Rp 120.000.000 | Rp 180.000.000 | Rp 300.000.000 | Rp 190.000.000 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

Total Sampel Modul | Rp 550.000.000 | Rp 780.000.000 | Rp 1.180.000.000 | Rp 808.333.333 |

Nota: Hasil perhitungan dari sampel sebesar Rp 808.333.333.333 tepat dan juga masih berada dalam rentang biaya total dari Rp 800.000.000 yang tertera di piagam Proyek.
Cadangan Dana (15%): Cadangan dana sebesar Rp 675.000.000 telah dipersiapkan untuk mencegah kenaikan harga server karena mata uang yang melemah, perubahan skema API Kemenkes, atau kendala saat migrasi data.

2.4.
Bagian D: Manajemen Risiko & Kualitas

D.1.
Risk Register

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	Skor	Strategi Mitigasi Operasional
---	---	---	---	---	---	---
R-01	Organisasi	Penolakan/penyesuaian alur kerja dari dokter & perawat	4	4	16	Bikin sosialisasi intensif dan tunjuk Super User di tiap unit.
R-02	Teknis	Ekstraksi data lama gagal sehingga data rekam medis hilang	3	5	15	Uji coba migrasi data (dry-run) minimal 3 kali di server uji coba.
R-03	Eksternal	Pengiriman perangkat server fisik dari vendor terlambat	3	4	12	Buat aturan denda keterlambatan harian di dalam kontrak pembelian.
R-04	Eksternal	Perubahan struktur data atau skema API dari Kemenkes	3	4	12	Siapkan alokasi sprint cadangan khusus untuk penyesuaian API.
R-05	Teknis	Aplikasi menjadi lambat saat diakses bersamaan	3	3	9	Lakukan tes beban (stress testing) pakai JMeter sebelum dirilis.

D.2.
Expected Monetary Value (EMV) Analysis

Perhitungan potensi kerugian finansial dari risiko-risiko utama meliputi: Risiko R-01 (Penolakan Alur Kerja) sebesar 80% x Rp 350.000.000, sehingga menghasilkan total kerugian sebesar Rp 280.000.000; Risiko R-03 (Keterlambatan Server) sebesar 80% x Rp 400.000.000, sehingga menghasilkan nilai sebesar Rp 320.000.000; dan Risiko R-02 (Kegagalan Data) sebesar 60% x Rp 500.000.000, yang berjumlah Rp 300.000.000.

Total Kerugian EMV: Rp 900.000.000

Kebijakan Risiko: Karena estimasi kerugian risiko (Rp 900.000.000) lebih tinggi dari dana cadangan (Rp 675.000.000), tim memperketat pengawasan pada proses pembersihan data dan pelatihan staf agar risiko ini tidak benar-benar terjadi.

D.3.
Rencana Manajemen Kualitas

Standar Acuan: Standar ISO/IEC 25010, Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan aturan API SATUSEHAT.

Aktivitas Penjaminan Kualitas (QA): Peninjauan kode harian (Daily Code Review), pengecekan kualitas kode pakai SonarQube, dan evaluasi sprint.

Kegiatan Pengendalian Mutu (QC): Pengujian unit (JUnit), pengujian API (Postman), pengujian sistem (Selenium), pengujian beban (JMeter), pengujian keamanan (OWASP ZAP).

Target Kelayakan Rilis: Waktu respons < 3 detik untuk 1.000 pengguna secara bersamaan, uptime server minimal 99,5%, tidak ada bug fatal, cakupan kode minimal 80%.

2.5.
Bagian E: Sumber Daya Manusia, Komunikasi, & Pengadaan

E.1.
Struktur Tim & RACI Matrix

Proyek ini melibatkan 20 orang anggota tim (Project Manager, Tech Lead, Developers, Business Analyst, QA, Data Migration Specialists, Change Management, Trainer, dan Infrastructure Specialists).

| Aktivitas Utama Proyek | PM | Tech Lead | BA / PO | QA Lead | Data Lead | Change Lead |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Analisis Kebutuhan Alur | A | C | R | C | C | C |

| Kustomisasi Modul Aplikasi | C | R | C | I | I | I |

| Pengujian Sistem | I | C | C | R/A | C | I |

| Migrasi Data Database | C | C | C | I | R/A | I |

| Pelaksanaan Pelatihan | C | I | C | I | I | R/A |

| Peluncuran Go-Live | A | R | C | C | R | R |

Keterangan: R = Pelaksana, A = Penanggung Jawab Utama, C = Narasumber, I = Penerima Laporan.

Penyempurnaan Tim: Karena Tech Lead awal memiliki tugas terlalu banyak, kami menunjuk seorang Senior Developer sebagai Deputy Tech Lead untuk membantu mengawasi pengerjaan harian.

E.2.
Rencana Komunikasi & Pelaporan

Kick-off Meeting: 1 kali pada awal proyek bertemu langsung dengan semua manajer dan tim.

Standup Meeting Harian: Setiap pagi (15 menit) menggunakan Zoom / WhatsApp group untuk memperbincangkan perkembangan harian.

Sprint Planning & Sprint Review: Setiap 2 minggu sekali untuk menunjukkan prestasi hasil fitur baru.

Meeting Steering Committee: Pertemuan setiap bulan yang dilakukan bersama dengan Direktur Utama untuk memberikan laporan keberhasilan proyek.

Weekly Status Report: Laporan tertulis setiap minggu yang disampaikan setiap

E.3.

Manajemen Pengadaan Perangkat

Paket Server Hardware: Pengadaan 3 unit server (64 Core, RAM 256GB, SSD 4TB), 1 unit Storage Area Network (SAN 20TB), dan 1 unit Firewall (1Gbps).

Garansi pemeliharaan resmi selama 3 tahun.

Kriteria Evaluasi Vendor: Harga (30%), Spesifikasi Teknis (40%), Layanan SLA/Garansi (20%), dan Portofolio Vendor (10%).

Jenis Kontrak: Kontrak Harga Pasti (Firm Fixed Price Contract) agar anggaran tidak membengkak dan risiko kenaikan harga ditanggung vendor.

2.6.

Bagian F: Implementasi, Deployment, & Manajemen Perubahan

F.1.

Strategi Peluncuran Sistem (Deployment Strategy)

Peluncuran menggunakan kombinasi Pilot Project dan Phased Rollout agar tidak mengganggu operasional rumah sakit. Sistem dicoba dulu di satu unit sebelum dibuka ke unit lainnya.

Jadwal Peluncuran (Cutover Plan):

Minggu 1 - 2: Uji coba sistem pilot di Rawat Jalan.

Minggu 3: Penerapan di unit Rawat Inap.

Minggu 4: Aktivasi e-resep digital di Instalasi Farmasi.

Minggu 5 - 6: Integrasi ke Laboratorium dan Radiologi.

Minggu 7: Sinkronisasi Billing Kasir dan Klaim BPJS.

Minggu 8: Resmi dipakai penuh (Full Go-Live) di seluruh rumah sakit.

F.2.

Migrasi Data & Skenario Pemulihan Darurat

Proses migrasi: Pemetaan tabel → Pembersihan data → Pembuatan skrip ETL → Uji coba 3 kali → Validasi sampel → Eksekusi migrasi di jam sepi → Verifikasi hasil akhir.

Rencana Darurat (Rollback Plan): Jika data rusak/hilang lebih dari 5% saat migrasi, proses dibatalkan dan data lama dikembalikan (restore) dalam waktu kurang dari 2 jam.

Jika sistem baru crash total dalam 1 jam pertama pasca go-live, operasional sementara kembali menggunakan sistem lama.

F.3.

Pelatihan Pengguna & Change Management

- Jadwal Kelas Pelatihan: Super User (5 hari), Dokter (2 hari), Perawat (2 hari), Kasir/Admisi (3 hari), dan Staf Lab/Farmasi/Radiologi (2 hari).
- Manajemen Perubahan: Penerbitan SK Instruksi dari Direktur Utama, Rapat Terbuka (Town Hall), Layanan Posko Bantuan 24 Jam, Pemasangan Poster Alur Kerja, serta Penunjukan Dokter & Perawat Senior sebagai Super User Champions.

2.7.

Bagian G: Monitoring, Pengendalian, Evaluasi, & Penutupan

G.1.

Earned Value Management (EVM) - Evaluasi Minggu ke-12

Data minggu ke-12:

• Planned Value (PV) = Rp 600.000.000 Earned Value (EV) = Rp 450.000.000

• Actual Cost (AC) = Rp 540.000.000

• Budget at Completion (BAC) = Rp 4.500.000.000

Perhitungan Indikator:

• Schedule Performance Index (SPI): $SPI = EV / PV = 450.000.000 / 600.000.000 = 0,75$ (Nilai < 1,0 menunjukkan pengerjaan terlambat dari jadwal).

• Cost Performance Index (CPI): $CPI = EV / AC = 450.000.000 / 540.000.000 = 0,83$ (Nilai < 1,0 menunjukkan pengeluaran dana boros / over budget).

Proyeksi Perkiraan Biaya Akhir (EAC):

$$\text{EAC} = \text{AC} + [(\text{BAC} - \text{EV}) / (\text{CPI} \times \text{SPI})] = 540.000.000 + [(4.500.000.000 - 450.000.000) / (0,83 \times 0,75)] = \text{Rp } 7.046.024.096$$

Indeks Efisiensi Sisa Pekerjaan (TCPI):

Untuk kembali ke batas anggaran awal (Rp 4,5 Miliar), efisiensi kerja tim harus dinaikkan menjadi 1,02.

Catatan Pencatatan EVM: Angka PV Rp 600.000.000 pada minggu ke-12 ini murni merupakan pengeluaran operasional (OpEx) kustomisasi software.

Belanja modal (CapEx) seperti lisensi software (Rp 1,2 M) dan server (Rp 800 Juta) dicatat terpisah sebagai aset investasi awal agar tidak mengacaukan perhitungan performa tim sehari-hari.

G.2.

Project Closure Checklist

Penutupan Administratif: Pengiriman dokumen, tanda tangan pada Laporan Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), dan penutupan kontrak vendor.

Penutupan Teknis: Transfer hak akses (password), pengiriman kode program dan petunjuk penggunaan, dan pengetesan sistem pemulihan bencana.

Penutupan Keuangan: Penyusunan audit biaya proyek, penyelesaian tagihan yang belum diselesaikan, dan transfer dana sisa dari dana cadangan ke kas rumah sakit.

Penutupan SDM: Evaluasi kinerja tim, pembagian sertifikat, dan penyelesaian tim proyek.

G.3.
Rencana Pemeliharaan Sistem (Maintenance & SLA Plan)

Target SLA: Time for response of reporting critical problem 99.5%.

Jenis Maintenance: Corrective (bug fixing), Adaptive (adjustment rule Kemenkes), Perfective (system optimization), dan Preventive (routine backup data).

Budget Maintenance: Dialokasikan sekitar 15% - 20% dari budget customisasi, yang senilai Rp 675.000.000 - Rp 900.000.000 per tahun.

| Error!
Bookmark not defined.

|

| --- | --- |

| 1.
1. | 3 |

| 2.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 14 |

| 3.
| Error!
Bookmark not defined.
|

| 4.
| Error!
Bookmark not defined.
|

1. 1. Latar Belakang Kasus

Dalam rangka menyongsong Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Rekam Medis, maka rumah sakit di Indonesia harus menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS yang langsung terkoneksi ke platform nasional SATUSEHAT oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Hanspital adalah rumah sakit kelas B yang kapasitasnya mencapai 300 tempat tidur dan sekarang rumah sakit tersebut belum menggunakan sistem informasi yang sudah terintegrasi serta pencatatan data sebagian besar dilakukan secara manual.

Maka dari itu, karena belum adanya hubungan yang baik di antara satu bagian dengan bagian lain, sering kali data ganda dan terjadi kesalahan pencatatan rekam medis dan proses pelayanan pasien menjadi tidak efektif.

Berdasarkan beberapa penelitian, penerapan SIMRS yang telah terintegrasi ternyata dapat mampu menurunkan kesalahan pencatatan data pasien, terutama pada bagian diagnosis penyakit dan berkas klaim BPJS Kesehatan.

Hal ini diperlukan agar rumah sakit tidak mengalami masalah.

Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) serta integrasinya ke dalam SATUSEHAT menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan standar layanan dan pertukaran informasi kesehatan yang lebih baik.

Proyek ini dirancang untuk memperkenalkan sistem aplikasi SIMRS yang terintegrasi dengan 7 modul yang meliputi: registrasi pasien, rekam medis elektronik, kalender klinik, apotek, laboratorium, radiologi, billing kasir, hingga asuransi. Semua modul ini dikoneksikan secara real-time ke SATUSEHAT.

Proyek ini dikembangkan untuk mengimplementasikan sistem SIMRS yang terintegrasi dan berisi 7 modul: pendaftaran pasien, rekam medis, jadwal poliklinik, farmasi, laboratorium, radiologi, billing, cashier sampai claim insurance. Semua modul tersebut terintegrasi secara real-time dengan SATUSEHAT.

000.

2. 1. 1. Project Charter (Piagam Proyek)

Aspek Proyek	Keterangan Detail
---	---
Nama Proyek	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Terintegrasi Regulasi
Sponsor Utama	Direktur Utama RS Hanspital
Manajer Proyek	Raihan Isad
Tanggal Otorisasi	1 Agustus 2026
Tujuan Strategis	- Membuat sistem rekam medis elektronik sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022. - Meningkatkan efisiensi kerja rumah sakit lewat otomatisasi. - Menghubungkan data rumah sakit ke platform SATUSEHAT Kemenkes.
	- Mengurangi kesalahan input berkas klaim BPJS agar tidak rugi. - Mendorong rumah sakit mengurangi penggunaan kertas.
---	---
Ruang Lingkup Makro	Kustomisasi dan pemasangan 7 modul utama SIMRS. Pembuatan sambungan API ke platform SATUSEHAT Kemenkes. Proses memindahkan (migrasi) data rekam medis dari sistem lama.
	Pelatihan penggunaan aplikasi untuk seluruh staf medis, perawat, dan admin. Beli dan pasang infrastruktur TI (server, jaringan, dan keamanan). Pengujian sistem, simulasi beban kerja, dan peluncuran (cutover).

| Batasan Eksplisit | - Menggunakan aplikasi dari vendor yang sudah jadi. -
Tidak termasuk membeli perangkat keras alat medis fisik. -
Tidak membuat integrasi ke asuransi swasta luar negeri. -
Pembuatan aplikasi mobile pasien ditunda untuk fase berikutnya.
|

| Estimasi Durasi | Total waktu proyek adalah 24 minggu (termasuk persiapan, pengadaan, dan pendampingan pasca peluncuran) dengan berbasis 6 hari kerja per minggu.
|

| Faktor Sukses Kunci | Komitmen dan dukungan dari pihak pimpinan dan direksi.
Kerjasama yang baik dari dokter, perawat, dan staf admin.
Kebersihan dan ketepatan data hasil migrasi dari sistem lama.
Penggunaan pelatihan user secara efektif sebelum penggunaan sistem.
Performa aplikasi yang cepat dan jarang mengalami lamban.
000

Risiko Utama Tingkat Tinggi:

R-01: Staf medis menolak atau sulit beradaptasi dengan alur kerja baru di komputer.

R-02: Pengambilan data lama gagal sehingga data rekam medis hilang atau rusak.

R-03: Pengiriman server dari vendor terlambat.

R-04: Format API SATUSEHAT mendadak berubah dari Kemenkes.

Wewenang Manajer Proyek:

Mengelola penggunaan dana proyek sendiri selama variasi perubahan biaya di bawah 10%.

Menyusun dan mengatur anggota tim proyek bekerja sama dengan HRD.

Mengambil keputusan harian terkait penyesuaian jadwal dan tugas tim.

Menyetujui usulan perubahan lingkup proyek kategori kecil (minor change request).

- Melaporkan perkembangan proyek secara langsung ke Sponsor Utama dan Steering Committee.

2. 000. 000 per tahun.

Berdasarkan manfaat nyata berupa kas masuk, diperoleh Payback Period selama 12,3 tahun dan nilai Return on Investment (ROI) untuk jangka waktu 5 tahun berjumlah -34%.

Meskipun ROI tampak negatif bila dihitung berdasarkan pendapatan kas bersih saja, investasi ini masih menjadi investasi yang benar-benar worth it dan harus dilakukan.

Identifikasi Stakeholder & Power/Interest Grid

Pemetaan pemangku kepentingan dilakukan menggunakan matriks tingkat pengaruh (Power) dan kepentingan (Interest):

- Kuadran A (High Power, Low Interest - Keep Satisfied): Perwakilan Asuransi Komersial Eksternal, Komite Etik Kedokteran Rumah Sakit.
- Kuadran B (High Power, High Interest - Manage Closely): Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medis, Kepala IT (CIO), Vendor SIMRS, Dinas Kesehatan, serta Kepala Rekam Medis, Kepala Farmasi, dan Kepala Laboratorium.
- Kuadran C (Power Low, Interest High - Inform): Staff Registration, Specialist/Dokter Umum, Nurse Implementer, dan Keuangan.
- Kuadran D (Power Low, Interest Low - Monitor): Pasien dan Keluarga Pasien.

2. 1. 2.

Scope Statement & Scope Baseline

- Fitur Dalam Lingkup (In-Scope): 7 Modul SIMRS (Pendaftaran, Rekam Medis Elektronik, Jadwal Poli, Farmasi, Laboratorium & Radiologi, Billing & Klaim BPJS, serta API SATUSEHAT Kemenkes).
 - Luar Lingkup (Out-of-Scope): Aplikasi mobile Android/iOS pasien, integrasi asuransi luar negeri, beli alat medis fisik, buat sistem dari nol, dan pengaplikasian di rumah sakit cabang.
- 5%, accuracy migrasi data sebesar 100%, dan semua staf melewati uji coba penggunaan aplikasi. serta Integrasi API SATUSEHAT Kementerian Kesehatan RI untuk mapping data variabel kesehatan, recording transaction medis sesuai regulasi, serta mengirim data otomatis secara aman.

3. Product Backlog (Sistem Agile Scrum)

Pengelompokan fitur menggunakan metode MoSCoW:

- Must Have (Wajib Ada):
 - US-01: Sebagai petugas pendaftaran, saya ingin mendaftarkan pasien baru dengan cepat agar pasien langsung dapat nomor rekam medis.
 - US-02: Sebagai dokter spesialis, saya ingin menginput data rekam medis dan resep digital agar pencatatan rapi.
 - US-03: Sebagai dokter, saya ingin melihat riwayat penyakit pasien agar keputusan tindakan medis tepat.
 - US-04: Sebagai perawat, saya ingin menginput data tanda vital pasien agar terpantau tim medis.
 - US-05: Sebagai petugas farmasi, saya ingin melihat e-resep masuk dan stok obat agar penyiapan obat akurat.
 - US-06: Sebagai petugas kasir, saya ingin menghitung otomatis biaya tindakan dan BPJS agar proses bayar efisien.
 - US-07: Sebagai sistem, aplikasi wajib mengirimkan data medis ke SATUSEHAT agar sesuai aturan Kemenkes.

- Should Have (Sangat Penting):

US-08: Sebagai pasien, saya ingin melihat tampilan nomor antrean di layar ruang tunggu.

US-09: Sebagai manajer medis, saya ingin melihat dashboard ketersediaan tempat tidur secara langsung.

US-10: Sebagai staf admin, saya ingin mengubah jadwal praktik bulanan dokter.

• Could Have (Tambahan):

US-11: Sebagai direksi, saya ingin menerima ringkasan laporan pendapatan harian otomatis lewat email.

US-12: Sebagai petugas lab, saya ingin data mesin lab langsung masuk ke sistem SIMRS.

US-13: Sebagai perawat ICU, saya ingin sistem menampilkan peringatan jika hasil lab kritis keluar.

• Won't Have (Ditunda):

US-14: Sebagai pasien, saya ingin mengambil nomor antrean dari rumah pakai aplikasi hp.

US-15: Sebagai pasien, saya ingin konsultasi video call dengan dokter lewat aplikasi.

3. 1. Pemilihan Metodologi Proyek

Method yang diaplikasikan dalam proyek ini adalah Hybrid Method (Predictive CPM & Adaptive Agile Scrum). Alasan dari pemilihan metode tersebut disebabkan proses implementasi server secara fisik maupun proses migration database membutuhkan proses yang terstruktur, sehingga pengembangannya menggunakan metode Critical Path Method (CPM). Akan tetapi, modul sistem SIMRS dan API SATUSEHAT membutuhkan tingkat fleksibilitas yang tinggi, maka diolah dengan metode Agile Scrum dengan cycle time 2 minggu.

Untuk menghindari scope creep, kita memfilter kebutuhan berdasarkan skala MoSCoW priority. Kebutuhan dokumentasi yang sedikit dalam metode Agile dikendalikan dengan membuat peta arsitektur dan buku pedoman yang harus ada di setiap sprint.

Penjadwalan Jalur Kritis (CPM/PDM)

ID	Nama Aktivitas	Durasi (Hari)	Predecessor
---	---	---	---
A	Analisis Kebutuhan Fungsional Alur Klinis	10	-
B	Pengadaan Perangkat Server Hardware	14	A
C	Pemasangan & Konfigurasi Jaringan Server	10	B
D	Kustomisasi Modul Inti Aplikasi	15	A
E	Kustomisasi Modul Penunjang Klinis	10	D
F	Pembuatan API SATUSEHAT	12	D

- | G | Persiapan & Skrip ETL Migrasi Data | 12 | A, C |
- | H | Pengujian Integrasi Sistem Keseluruhan | 12 | C, D, E, F |
- | I | Pengujian User Acceptance Testing (UAT) | 10 | H, G |
- | J | Pelatihan Kelompok Super User | 8 | H |
- | K | Pelatihan Kelompok Staf Massal | 12 | J |
- | L | Eksekusi Migrasi Data Produksi (Cutover) | 5 | G, I |
- | M | Peresmian Transisi Go-Live Sistem Baru | 3 | I, K, L |
- | N | Pendampingan & Support Pasca Go-Live | 12 | M |

Analisis Penjadwalan:

Rute Jalur Kritis: A - D - F - H - J - K - M – N

Durasi Total Jalur Kritis Jalur Kritis: 84 Hari Kerja (atau 14 minggu,berdasarkan 6 hari kerja per minggu).

Explanasi Perbedaan Waktu: Waktu penerapan teknis adalah 84 hari kerja (sama dengan 14 minggu berdasarkan 6 hari kerja).

Perbedaan waktu sampai 24 minggu seperti yang dicantumkan dalam Project Charter adalah waktu buffer. Waktu tersebut diperlukan untuk keperluan administrasi awal, menunggu pengiriman server dari luar negeri, dan hypercare sistem pasca peluncuran (hypercare).

2. 000 yang tertera di piagam Proyek.
000 telah dipersiapkan untuk mencegah kenaikan harga server karena mata uang yang melemah, perubahan skema API Kemenkes, atau kendala saat migrasi data.

4. 1. Risk Register

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	P	D	Skor	Strategi Mitigasi Operasional
---	---	---	---	---	---	---
R-01	Organisasi	Penolakan/penyesuaian alur kerja dari dokter & perawat	4	4	16	Bikin sosialisasi intensif dan tunjuk Super User di tiap unit.
R-02	Teknis	Ekstraksi data lama gagal sehingga data rekam medis hilang	3	5	15	Uji coba migrasi data (dry-run) minimal 3 kali di server uji coba.
R-03	Eksternal	Pengiriman perangkat server fisik dari vendor terlambat	3	4	12	Buat aturan denda keterlambatan harian di dalam kontrak pembelian.

|

| R-04 | Eksternal | Perubahan struktur data atau skema API dari Kemenkes | 3 | 4 | 12 | Siapkan alokasi sprint cadangan khusus untuk penyesuaian API.

| R-05 | Teknis | Aplikasi menjadi lambat saat diakses bersamaan | 3 | 3 | 9 | Lakukan tes beban (stress testing) pakai JMeter sebelum dirilis.

2.

000), tim memperketat pengawasan pada proses pembersihan data dan pelatihan staf agar risiko ini tidak benar-benar terjadi.

3. Rencana Manajemen Kualitas

Standar Acuan: Standar ISO/IEC 25010, Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan aturan API SATUSEHAT.

Aktivitas Penjaminan Kualitas (QA): Peninjauan kode harian (Daily Code Review), pengecekan kualitas kode pakai SonarQube, dan evaluasi sprint.

Kegiatan Pengendalian Mutu (QC): Pengujian unit (JUnit), pengujian API (Postman), pengujian sistem (Selenium), pengujian beban (JMeter), pengujian keamanan (OWASP ZAP).

000 pengguna secara bersamaan, uptime server minimal 99,5%, tidak ada bug fatal, cakupan kode minimal 80%.

5. 1. Struktur Tim & RACI Matrix

Proyek ini melibatkan 20 orang anggota tim (Project Manager, Tech Lead, Developers, Business Analyst, QA, Data Migration Specialists, Change Management, Trainer, dan Infrastructure Specialists).

| Aktivitas Utama Proyek | PM | Tech Lead | BA / PO | QA Lead | Data Lead | Change Lead |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Analisis Kebutuhan Alur | A | C | R | C | C | C |

| Kustomisasi Modul Aplikasi | C | R | C | I | I | I |

| Pengujian Sistem | I | C | C | R/A | C | I |

| Migrasi Data Database | C | C | C | I | R/A | I |

| Pelaksanaan Pelatihan | C | I | C | I | I | R/A |

| Peluncuran Go-Live | A | R | C | C | R | R |

Keterangan: R = Pelaksana, A = Penanggung Jawab Utama, C = Narasumber, I = Penerima Laporan.

Penyempurnaan Tim: Karena Tech Lead awal memiliki tugas terlalu banyak, kami menunjuk seorang Senior Developer sebagai Deputy Tech Lead untuk membantu mengawasi pengerjaan harian.

2. Rencana Komunikasi & Pelaporan

Kick-off Meeting: 1 kali pada awal proyek bertemu langsung dengan semua manajer dan tim.

Standup Meeting Harian: Setiap pagi (15 menit) menggunakan Zoom / WhatsApp group untuk memperbincangkan perkembangan harian.

Sprint Planning & Sprint Review: Setiap 2 minggu sekali untuk menunjukkan prestasi hasil fitur baru.

Meeting Steering Committee: Pertemuan setiap bulan yang dilakukan bersama dengan Direktur Utama untuk memberikan laporan keberhasilan proyek.

3. Manajemen Pengadaan Perangkat

Paket Server Hardware: Pengadaan 3 unit server (64 Core, RAM 256GB, SSD 4TB), 1 unit Storage Area Network (SAN 20TB), dan 1 unit Firewall (1Gbps).

Garansi pemeliharaan resmi selama 3 tahun.

Kriteria Evaluasi Vendor: Harga (30%), Spesifikasi Teknis (40%), Layanan SLA/Garansi (20%), dan Portofolio Vendor (10%).

Jenis Kontrak: Kontrak Harga Pasti (Firm Fixed Price Contract) agar anggaran tidak membengkak dan risiko kenaikan harga ditanggung vendor.

6. 1. Strategi Peluncuran Sistem (Deployment Strategy)

Peluncuran menggunakan kombinasi Pilot Project dan Phased Rollout agar tidak mengganggu operasional rumah sakit. Sistem dicoba dulu di satu unit sebelum dibuka ke unit lainnya.

Jadwal Peluncuran (Cutover Plan):

Minggu 1 - 2: Uji coba sistem pilot di Rawat Jalan.

Minggu 3: Penerapan di unit Rawat Inap.

Minggu 4: Aktivasi e-resep digital di Instalasi Farmasi.

Minggu 5 - 6: Integrasi ke Laboratorium dan Radiologi.

Minggu 7: Sinkronisasi Billing Kasir dan Klaim BPJS.

Minggu 8: Resmi dipakai penuh (Full Go-Live) di seluruh rumah sakit.

2. Migrasi Data & Skenario Pemulihan Darurat

Proses migrasi: Pemetaan tabel → Pembersihan data → Pembuatan skrip ETL → Uji coba 3 kali → Validasi sampel → Eksekusi migrasi di jam sepi → Verifikasi hasil akhir.

Rencana Darurat (Rollback Plan): Jika data rusak/hilang lebih dari 5% saat migrasi, proses dibatalkan dan data lama dikembalikan (restore) dalam waktu kurang dari 2 jam.

Jika sistem baru crash total dalam 1 jam pertama pasca go-live, operasional sementara kembali menggunakan sistem lama.

3. Pelatihan Pengguna & Change Management

- Jadwal Kelas Pelatihan: Super User (5 hari), Dokter (2 hari), Perawat (2 hari), Kasir/Admisi (3 hari), dan Staf Lab/Farmasi/Radiologi (2 hari).
- Manajemen Perubahan: Penerbitan SK Instruksi dari Direktur Utama, Rapat Terbuka (Town Hall), Layanan Posko Bantuan 24 Jam, Pemasangan Poster Alur Kerja, serta Penunjukan Dokter & Perawat Senior sebagai Super User Champions.

7. 1. 000 = 0,75 (Nilai < 1,0 menunjukkan pengerjaan terlambat dari jadwal).

000 = 0,83 (Nilai < 1,0 menunjukkan pengeluaran dana boros / over budget).

096

Indeks Efisiensi Sisa Pekerjaan (TCPI):

Untuk kembali ke batas anggaran awal (Rp 4,5 Miliar), efisiensi kerja tim harus dinaikkan menjadi 1,02.

000 pada minggu ke-12 ini murni merupakan pengeluaran operasional (OpEx) kustomisasi software. Belanja modal (CapEx) seperti lisensi software (Rp 1,2 M) dan server (Rp 800 Juta) dicatat terpisah sebagai aset investasi awal agar tidak mengacaukan perhitungan performa tim sehari-hari.

2. Project Closure Checklist

Penutupan Administratif: Pengiriman dokumen, tanda tangan pada Laporan Penyelesaian Pekerjaan (BAPP), dan penutupan kontrak vendor.

Penutupan Teknis: Transfer hak akses (password), pengiriman kode program dan petunjuk penggunaan, dan pengetesan sistem pemulihan bencana.

Penutupan Keuangan: Penyusunan audit biaya proyek, penyelesaian tagihan yang belum diselesaikan, dan transfer dana sisa dari dana cadangan ke kas rumah sakit.

Penutupan SDM: Evaluasi kinerja tim, pembagian sertifikat, dan penyelesaian tim proyek.

3. 5%.

Jenis Maintenance: Corrective (bug fixing), Adaptive (adjustment rule Kemenkes), Perfective (system optimization), dan Preventive (routine backup data).

000 per tahun.